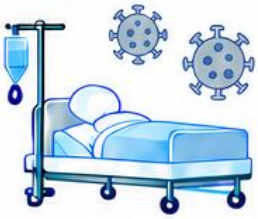
疫苗守護肺癌病人

預防感染・減少重症・守護治療之路更安心

1 為什麼肺癌病人更需要打疫苗？



感染是肺癌病人在診斷後
第一年內，除了肺癌本身之外的
第二大主要死因。

肺癌本身或化療等療程會
暫時削弱免疫系統，
使併發嚴重感染的風險
顯著高於一般人。



接種非活性疫苗的目的

不僅是「預防感染」，
更重要的是在不慎感染時
大幅減輕症狀嚴重度、
降低住院率與死亡風險。



2 疫苗對肺癌病人的保護力有多少？

根據 **美國臨床腫瘤學會** 臨床指引引用的多項大型研究數據，非活性疫苗能為肺癌病人提供顯著的保護效果，依疫苗別的不同，提升約 **50-90%** 的保護力。



3 溫馨提醒與防護建議



依醫師建議
接種適合的
非活性疫苗。



在人多或流行期間
配戴口罩、勤洗手、
維持良好個人衛生。



避免前往
人多擁擠的場所。



保持均衡飲食、
適度運動，充足睡眠，
維持良好免疫力。

疫苗是肺癌治療路上的重要守護夥伴，
讓您更安心，也更有力量面對治療！

經費贊助

高雄醫學大學附設中和紀念醫院
癌症中心肺癌團隊｜胸腔內科

2026.11

肺癌病人疫苗施打建議

疫苗種類	公費施打對象	自費價格	補充說明
 流感疫苗	重大疾病，符合公費施打	—	• 每年流感季前接種。
 肺炎鏈球菌疫苗	• 65 歲以上、55-64 歲原住民 • 19-64 歲 IPD 高風險者(含一年內接受免疫抑制劑、化學治療、標靶治療或放療之惡性腫瘤者)	• **PCV20**：約 4500 元 • **PCV21**：依院所供應	• 沒打過 → PCV20/21 打一劑 • 打過 PCV13 → 一年後補打 PCV20/21 • 打過 PCV23 → 一年後補打 PCV20/21
 新冠疫苗	重大疾病，符合公費施打	—	• 依變異株追加更新劑型。 • 莫德納 (Moderna) 為 mRNA 疫苗，Novavax 則為重組蛋白疫苗，可供不適合 mRNA 者。 • 免疫不全或免疫低下者，接種後間隔 6 個月以上，可再增加接種 1 劑。
 帶狀疱疹疫苗	無公費	• Shingrix：約 9000 元/劑；共 2 劑。	• 非活性基因重組疫苗，需接種 2 劑，標準為間隔 2-6 個月施打第二劑，但癌症病人可在臨床醫師考量病情需求後，間隔四周施打第二劑。 • 局部/全身反應較明顯。 • 孕婦應避免接種。
 呼吸道融合病毒疫苗	無公費	• Arexvy：約 7700 元/劑 • Abrysvo：約 7700 元/劑	• Arexvy 含佐劑，對年長及免疫力低下者反應較佳，但注射反應較大，不可用於孕婦。 • Abrysvo 無佐劑，孕婦 24-36 週可接種以保護新生兒。
 百日咳疫苗	無公費	• Boostrix：約 1500 元/劑 • Adacel：約 1500 元/劑	• 減量破傷風 + 白喉 + 非細胞性百日咳。 • 每十年追加。 • Boostrix 與 Adacel 同類可替代，但抗原配比略有差異。

※ 溫馨提醒：接種前請先與主治醫師確認是否適合施打及接種時機；疫苗公費資格與自費價格可能變動，請以最新公告及院所資訊為準。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院
癌症中心肺癌團隊 | 胸腔內科

經費贊助

2026.11